

정상 작동한 AI 돌봄의 실패

핵심 문장: 2036년의 실패는 AI 오작동이 아니었다. AI는 위험 점수를 낮추고 방문 우선순위를 최적화했다. 다만 2026년의 우리가 돌봄의 목표에서 사람의 방문과 관계망을 지워버렸다.

01

예견된 실패

2036년 공공 AI 돌봄망은 독거노인의 복약, 수면, 낙상, 심박, 냉장고 사용량을 실시간으로 관리한다. 대시보드는 대부분 파란색이고 담당자는 "방문 불필요" 판정을 받는다. 그러나 챗봇의 "괜찮아요" 버튼 뒤에서 실제 대화는 줄고, 이웃의 방문과 생활지원사의 대면 확인은 예산 효율화라는 이름으로 사라진다. 고립은 사고가 아니라 표준 운영값이 된다.

02

원인 진단

출발점은 2026년의 지표 설계다. 우리는 돌봄의 성공을 관계 회복, 도움 요청 가능성, 대면 신뢰가 아니라 처리 건수, 비용 절감, 위험 점수 하락으로 측정하기 시작했다. 정량화 가능한 생체 신호는 핵심 데이터가 됐지만 말수가 줄어드는 변화, 도움을 망설이는 침묵, 이웃의 관찰은 "비정형"이라는 이유로 주변부가 됐다.

03

대응 방안

AI 돌봄을 편의 기능이 아니라 고위험 공공 서비스 인프라로 다룬다. 정부와 운영기관은 위험 점수와 무관한 월 1회 대면 접촉 최저선, 자동 판단 책임 로그, 당사자의 AI 돌봄 거부·전환권, 지역 연락망 지표를 의무화한다. 기업은 정확도뿐 아니라 관계 단절을 늘리지 않는지 사전 실패 테스트를 통과해야 한다.

2036년의 실패 로그

- 07:10 대시보드는 정상: 복약과 심박은 안정, 방문은 자동 연기.
- 14:30 "괜찮아요" 응답 완료: 도움 거절이 아니라 말문 닫힘이었다.
- 21:05 아무도 문을 두드리지 않음: AI가 위험을 낮추며 관계도 낮췄다.

근거와 평가 기준

- 사회적 연결은 건강·사망 위험과 연결되는 공중보건 이슈다.
- 공공 서비스 AI는 위험관리, 기록, 인간 감독이 필요한 고위험 인프라다.
- 위험 점수는 사람의 판단을 더 위험 회피적으로 재구성할 수 있다.

참고 근거: U.S. Surgeon General(2023), Holt-Lunstad et al.(2015), NIST AI RMF(2023), EU AI Act, Green & Chen(2021), Green(2022).